



Comportements addictifs chez les étudiants Stress académique et stratégies de gestion Résultats d'une enquête

Aude Bernier - Clara Pierreuse - Justine Reiter–Guerville

Janvier 2026 – Année Universitaire 2025/2026

Master Monnaie Banque Finance Assurance

Parcours Système d'information économique et financier

Université de Montpellier

Sous la supervision de : Madame Cucurullo Vanessa

Table des matières

Partie 1 – Méthodologie.....	2
1. Enjeux, objectifs et périmètre du projet.....	2
1.1 Contexte et enjeux.....	2
1.2 Problématique.....	3
1.3 Objectifs de l'étude.....	3
1.4 Périmètre de l'étude.....	3
2. Techniques de collecte de l'information.....	4
2.1 Recherche bibliographique.....	4
2.2 Enquête quantitative par questionnaire.....	4
2.3 Modalités de diffusion.....	5
3. Organisation du projet et gestion des tâches.....	5
3.1 Planning du projet.....	5
3.2 Répartition des tâches au sein du groupe.....	6
Partie 2 – Résultats.....	7
1. État des lieux des comportements et du contexte étudiant.....	7
1.1 Comportements addictifs observés : état des lieux.....	7
1.2 Analyse descriptive par type de comportement addictif.....	8
2. Analyse des liens entre stress et comportements addictifs.....	12
2.1 Stress académique stratégies de gestion.....	12
2.2 Stratégies de gestion.....	13
3. Discussion et recommandations.....	17
3.1 Analyses croisées et interprétation.....	17
3.2 Lecture transversale des tableaux croisés.....	21
3.3 Mise en perspective et limites de l'étude.....	22
3.4 Préconisations et pistes d'action.....	24
Annexes.....	25
Annexe A – Questionnaire.....	25
Annexe B – Bibliographie et webographie.....	42

Partie 1 – Méthodologie

1. Enjeux, objectifs et périmètre du projet

1.1 Contexte et enjeux

Les comportements addictifs constituent un enjeu majeur de santé publique, en particulier chez les jeunes adultes et les étudiants.

Selon les organismes spécialisés, une addiction comportementale se définit comme « un trouble addictif lié à une activité ou à un comportement, en l'absence de consommation de toute substance psychoactive », pouvant entraîner une perte de contrôle, une dépendance psychologique ainsi que des conséquences négatives sur la santé, la vie sociale et le bien-être de l'individu.

Cette définition est notamment retenue par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) dans ses travaux de synthèse sur les addictions comportementales, publiés en 2018.

Dans le cadre de cette étude, le choix méthodologique a été fait de se concentrer exclusivement sur les addictions comportementales associées à des pratiques de consommation courantes, telles que l'alimentation, le tabac et l'alcool. Ce périmètre volontairement restreint permet de cibler des comportements largement accessibles et banalisés dans le milieu universitaire, contrairement à d'autres formes d'addictions plus sévères ou marginales.

La période universitaire constitue un cadre d'analyse pertinent pour l'étude des comportements addictifs, dans la mesure où elle correspond, pour une large majorité d'étudiants, à une phase de transition marquée par une autonomie accrue et une réorganisation des rythmes de vie. Cette évolution s'accompagne souvent d'une augmentation du stress académique et d'une responsabilisation plus importante dans la gestion du quotidien, sans que ces éléments ne s'appliquent de manière uniforme à l'ensemble des étudiants.

Par ailleurs, l'environnement universitaire peut favoriser l'accessibilité à certains produits de consommation courante. La présence fréquente de distributeurs automatiques dans les établissements d'enseignement supérieur rend notamment les produits sucrés ou caféinés facilement disponibles, pouvant s'inscrire dans des usages perçus comme fonctionnels face à la fatigue ou aux contraintes académiques.

Enfin, l'entrée dans l'enseignement supérieur coïncide généralement avec l'accès à la majorité légale, ouvrant un accès réglementé au tabac et à l'alcool et s'accompagnant d'un élargissement du réseau social. Sans constituer une réalité systématique, ce contexte contribue à expliquer pourquoi la période universitaire est souvent considérée comme un

moment clé dans l'émergence ou l'évolution de comportements addictifs socialement acceptés et largement banalisés.

Dans ce cadre, il apparaît essentiel de mieux comprendre comment ces addictions comportementales se manifestent chez les étudiants, ainsi que les facteurs susceptibles de les influencer, tels que le stress perçu.

Cette étude s'inscrit ainsi dans une démarche d'analyse et de prévention, visant à produire des résultats exploitables afin de mieux sensibiliser la population étudiante et de proposer des pistes d'actions adaptées au contexte universitaire.

1.2 Problématique

Quels comportements addictifs sont les plus présents chez les étudiants, et comment ces comportements sont-ils liés à leurs conditions de vie universitaire (stress, habitudes quotidiennes, niveau d'études) ?

Cette problématique vise à dépasser un simple état des lieux descriptif pour identifier des relations entre pratiques addictives et variables explicatives, permettant de dégager des profils types et des leviers d'action.

1.3 Objectifs de l'étude

- Identifier les principales formes d'addictions (substances et comportements) chez les étudiants interrogés
- Mesurer la fréquence et l'intensité de ces comportements
- Analyser le lien entre comportements addictifs et variables individuelles (âge, sexe, niveau d'études)
- Comparer, lorsque cela est pertinent, les résultats obtenus avec les constats issus de la littérature existante
- Formuler des recommandations de prévention adaptées au public étudiant

1.4 Périmètre de l'étude

La population interrogée est composée d'étudiants de l'enseignement supérieur, ayant répondu à un questionnaire en ligne anonyme diffusé dans le cadre d'un projet universitaire de techniques d'enquête.

La zone géographique retenue est la France qui se justifie par le fait que les conditions de vie étudiante, les niveaux d'éducation ainsi que l'accès à certaines pratiques de consommation diffèrent fortement selon les pays. Se concentrer sur le contexte français permet ainsi de garantir une meilleure homogénéité des résultats et une interprétation plus cohérente.

Au total, 209 étudiants ont répondu au questionnaire. Après un travail de vérification et de nettoyage des données, un questionnaire a été écarté en raison de réponses jugées non cohérentes. L'analyse repose donc sur un échantillon final composé de 208 répondants.

Les addictions étudiées sont les suivantes :

Alimentations (sucre, sel, caféine, boissons énergisantes, alcool)
Tabac
Cannabis
Cocaïne
Médicaments

2. Techniques de collecte de l'information

2.1 Recherche bibliographique

Afin de poser un cadre conceptuel solide, un travail de recherche bibliographique a été réalisé en amont de cette étude. Celui-ci a permis de définir précisément les notions d'addiction et de dépendance, d'identifier les seuils de consommation généralement retenus dans la littérature, et de situer l'étude dans un cadre théorique et empirique existant.

Une attention particulière a été portée à la définition des unités de mesure utilisées dans les études de référence (fréquences de consommation, quantités, seuils de risque), celles-ci constituant un élément central pour garantir la comparabilité des résultats. Cette homogénéité des indicateurs permet de confronter les données issues de l'enquête aux constats établis par la littérature scientifique et institutionnelle, et d'en assurer une interprétation rigoureuse.

2.2 Enquête quantitative par questionnaire

La méthode principale de collecte repose sur une enquête quantitative, administrée via un questionnaire en ligne.

Le questionnaire a été conçu conformément aux principes méthodologiques suivant :

- Questions claires, non ambiguës et accessibles
- Combinaison de questions fermées, échelles et questions quantitatives
- Structuration progressive (mise en confiance, thématiques, variables sociodémographiques en fin de questionnaire)
- Limitation du nombre de questions afin de favoriser le taux de réponse

Le questionnaire couvre plusieurs dimensions :

- Profil sociodémographique
- Habitudes de consommation
- Perception du caractère addictif
- Difficulté à réduire ou arrêter certaines consommations
- Facteurs explicatifs (stress, sommeil, activité physique)

Avant diffusion, le questionnaire a été testé et ajusté auprès de plusieurs individus correspondant au public ciblé, afin de garantir sa compréhension et la cohérence des réponses.

2.3 Modalités de diffusion

La diffusion du questionnaire a été réalisée selon une stratégie multicanale, afin de toucher des étudiants issus de différentes filières et établissements. Le lien vers le questionnaire a notamment été partagé :

- au sein de groupes WhatsApp d'étudiants, regroupant des étudiants de différentes facultés ;
- par le biais d'affiches apposées dans plusieurs établissements universitaires, invitant les étudiants à participer à l'enquête ;
- via le réseau social Instagram, utilisé comme canal de diffusion informel auprès de la population étudiante.

3. Organisation du projet et gestion des tâches

3.1 Planning du projet

Étape	Description	Période
1	Définition de la problématique et des objectifs	1 semaine
2	Recherche bibliographique	1 semaine
3	Construction du questionnaire	2 semaines
4	Diffusion et collecte des réponses	2 mois
5	Nettoyage et préparation des données	1 semaine
6	Analyses statistiques descriptives et croisées	2 semaines
7	Rédaction du rapport et du PowerPoint	2 semaines

La période de collecte des données s'est étendue sur deux mois, afin de permettre une diffusion progressive du questionnaire et d'obtenir un volume de réponses suffisant. Cette temporalité a également facilité le bon enchaînement des phases suivantes du projet, notamment le nettoyage, l'analyse des données et la rédaction.

3.2 Répartition des tâches au sein du groupe

Le travail a été structuré de manière à mobiliser efficacement les compétences spécifiques de chaque membre du groupe et à favoriser une progression collective du projet. Bien que des rôles principaux aient été définis, l'ensemble des étapes s'inscrit dans une logique de communication permanente, de collaboration active et de relecture croisée, les décisions méthodologiques, les analyses et les choix rédactionnels faisant l'objet d'échanges réguliers afin de garantir la cohérence d'ensemble du travail.

Membre du groupe	Rôle principal	Tâches réalisées
Justine	Conception du questionnaire et appui à la valorisation des résultats	Élaboration du questionnaire, formulation des questions et des modalités de réponse, structuration des thématiques, participation aux phases de test et d'ajustement du questionnaire. Contribution à la réflexion sur la visualisation des résultats.
Aude	Traitement et analyse des données	Nettoyage et structuration de la base de données sous Excel, réalisation des tableaux croisés dynamiques, analyses statistiques descriptives et croisées, participation à l'interprétation des résultats et à la visualisation des données.
Clara	Coordination du projet et rédaction des livrables	Organisation et coordination du projet, définition de la problématique et des objectifs, participation au nettoyage de la base de données, rédaction du rapport et des supports de présentation, mise en cohérence des différentes parties, synthèse et reformulation des résultats.

Partie 2 – Résultats

1. État des lieux des comportements et du contexte étudiant

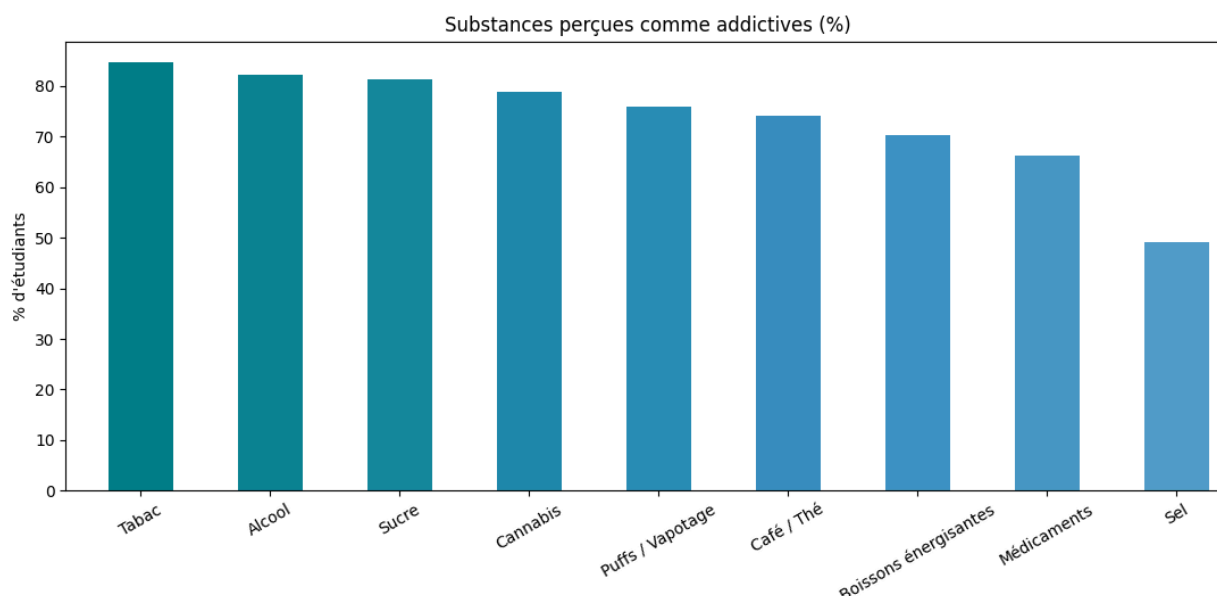
Cette première section vise à dresser un état des lieux de la population interrogée et des comportements observés. Elle repose exclusivement sur les données issues du questionnaire et a pour objectif de présenter les principaux résultats descriptifs, afin d'en dégager les principales tendances.

1.1 Comportements addictifs observés : état des lieux

Les réponses au questionnaire mettent en évidence une diversité de comportements de consommation chez les étudiants, révélant des rapports contrastés à ces pratiques dans le cadre universitaire. Une part significative des répondants déclare se percevoir comme addictive à au moins une substance consommable, ce qui souligne que la question des comportements addictifs occupe une place importante dans les représentations étudiantes.

L'analyse des réponses montre également que la perception de ce qui constitue une addiction comportementale varie selon les types de consommation. Les substances les plus fréquemment identifiées comme addictives sont celles bénéficiant déjà d'une reconnaissance sociale et institutionnelle forte, telles que le tabac, l'alcool ou le cannabis. À l'inverse, certaines consommations plus banalisées dans le quotidien étudiant, comme le café ou certains produits alimentaires, sont moins systématiquement perçues comme addictives, malgré leur présence régulière et parfois intensive.

Cet état des lieux met ainsi en évidence un décalage entre la fréquence réelle de certaines pratiques et leur reconnaissance subjective comme comportements potentiellement addictifs, ouvrant la voie aux analyses développées dans les sections suivantes.



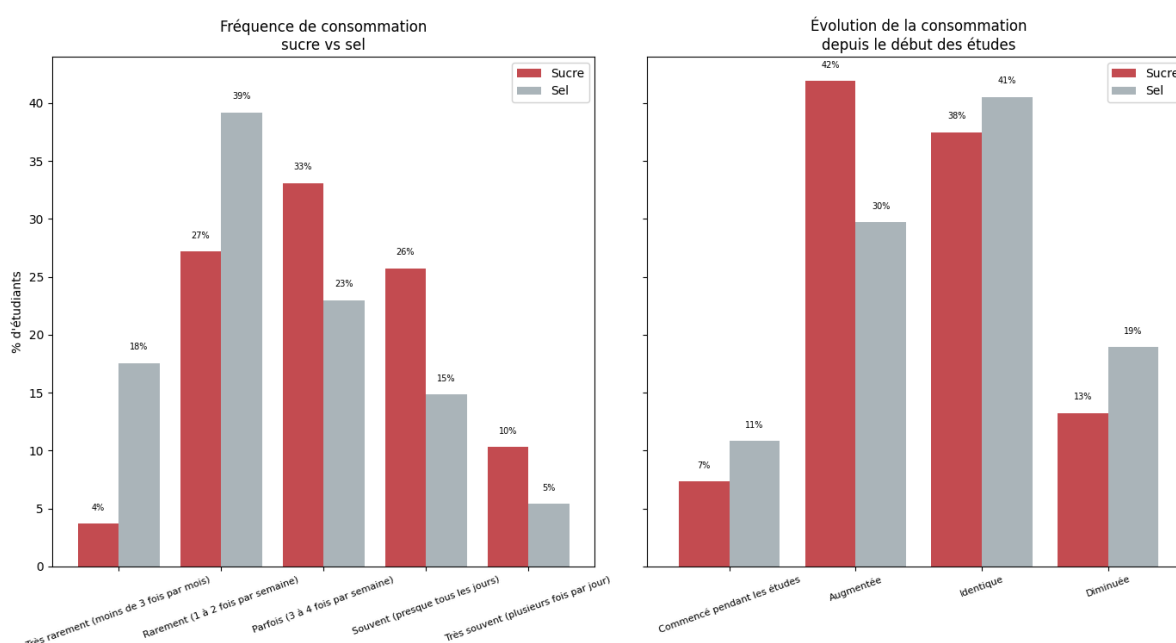
1.2 Analyse descriptive par type de comportement addictif

Habitudes alimentaires et grignotage

Les résultats mettent en évidence une forte banalisation du grignotage chez les étudiants, qu'il soit sucré ou salé. La consommation sucrée apparaît particulièrement marquée : près de 70 % des répondants déclarent consommer des produits sucrés au moins deux à quatre fois par semaine, et plus d'un tiers indique une consommation fréquente à très fréquente. Le grignotage salé, bien que largement répandu, s'inscrit davantage dans des rythmes hebdomadaires et demeure globalement moins intensif.

L'entrée dans l'enseignement supérieur semble jouer un rôle structurant dans ces pratiques. Une augmentation de la consommation est déclarée par 42 % des étudiants pour le sucré, contre 30 % pour le salé, suggérant une sensibilité accrue des produits sucrés aux contraintes du quotidien universitaire. Ces résultats confirment l'idée selon laquelle les exigences académiques, la fatigue et la gestion du stress favorisent des comportements alimentaires moins structurés.

Les périodes d'examens apparaissent comme des moments particulièrement propices à l'intensification du grignotage, renforçant l'hypothèse d'un usage compensatoire de l'alimentation face à la pression scolaire. Cette dynamique, déjà documentée dans la littérature, rejoint les travaux de l'OMS et de l'INSERM, qui soulignent le rôle du stress et du manque de temps dans la normalisation de comportements alimentaires déséquilibrés chez les jeunes adultes.

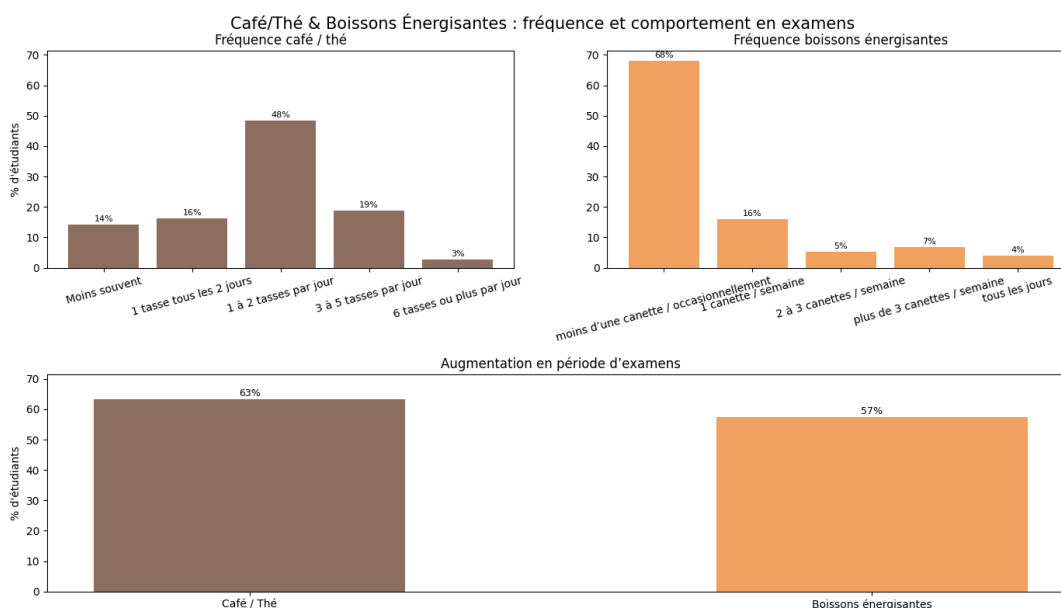


Café, thé et boissons énergétiques

La consommation de café et de thé apparaît comme un comportement largement intégré au quotidien étudiant. Près de la moitié des répondants déclarent consommer entre une et deux tasses par jour, tandis qu'une proportion non négligeable dépasse trois tasses quotidiennes, traduisant un usage régulier et structuré. Cette consommation s'inscrit majoritairement dans une logique fonctionnelle, orientée vers la gestion de la fatigue et le maintien de la concentration, plutôt que dans une logique de plaisir ou de sociabilité.

Les périodes d'examens constituent un facteur d'intensification notable de ces pratiques. En effet, 63 % des étudiants déclarent augmenter leur consommation de café ou de thé lors de ces phases de forte charge académique, soulignant le rôle central de ces substances comme outils d'adaptation aux exigences universitaires.

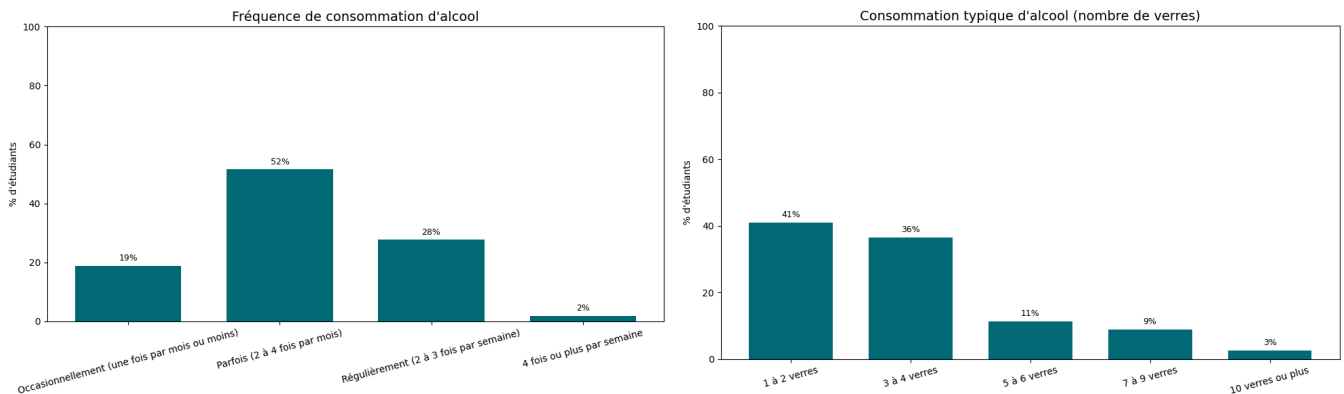
À l'inverse, les boissons énergisantes occupent une place plus marginale dans les habitudes de consommation. Leur usage demeure majoritairement occasionnel, avec une consommation hebdomadaire ou quotidienne limitée à une minorité d'étudiants. Néanmoins, leur recours augmente sensiblement en période d'examens, comme en témoigne une hausse déclarée par 57 % des répondants. Cette dynamique suggère une utilisation plus ciblée et circonstancielle de ces produits, mobilisés ponctuellement pour répondre à des besoins immédiats de vigilance ou d'endurance cognitive.



Alcool et substances socialement marquées

La consommation d'alcool concerne une majorité d'étudiants et s'inscrit principalement dans des contextes sociaux, tels que les soirées entre amis ou les événements festifs. Les résultats indiquent que plus de la moitié des répondants déclarent une consommation occasionnelle à régulière, avec 52 % consommant de l'alcool deux à quatre fois par mois et 28 % deux à trois fois par semaine.

L'analyse des quantités consommées met en évidence des usages majoritairement modérés. En effet, 41 % des étudiants déclarent consommer un à deux verres lors d'une occasion typique, tandis que 36 % indiquent une consommation de trois à quatre verres. Les consommations plus élevées demeurent marginales, suggérant que l'alcool est principalement intégré à des pratiques sociales encadrées plutôt qu'à des usages excessifs ou quotidiens.



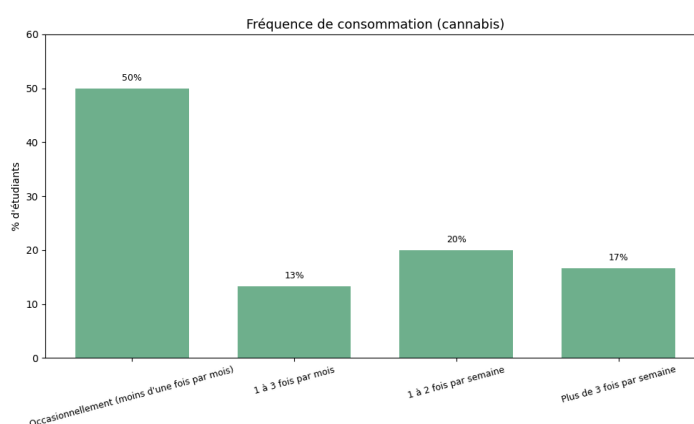
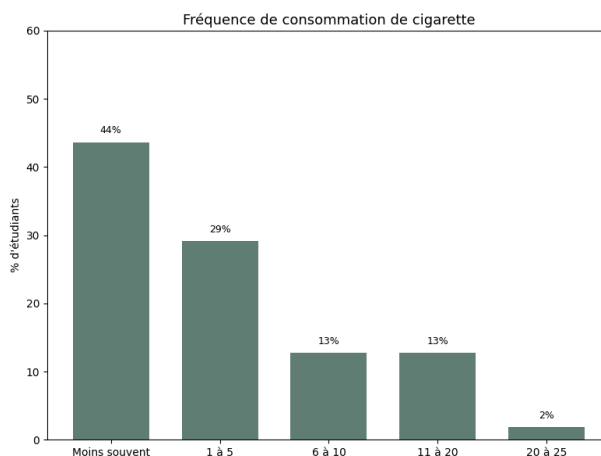
Tabac et Cannabis

La consommation de tabac et de cannabis concerne une part plus restreinte de la population étudiante interrogée et se caractérise par une forte hétérogénéité des usages. Pour le tabac, la majorité des répondants déclare une consommation faible ou occasionnelle, tandis qu'environ un tiers rapporte un usage quotidien modéré à régulier. Les consommations les plus intensives restent marginales, traduisant une polarisation des comportements fréquemment observée dans les enquêtes sur le tabagisme étudiant.

Ces résultats sont globalement cohérents avec les constats issus des enquêtes nationales, notamment celles de Santé publique France, qui mettent en évidence une baisse tendancielle du tabagisme chez les jeunes adultes, parallèlement au maintien d'un noyau d'usagers réguliers. La structure des consommations observée dans notre échantillon s'inscrit ainsi dans cette dynamique générale.

Concernant le cannabis, l'usage apparaît majoritairement occasionnel, près de la moitié des étudiants déclarant une consommation inférieure à une fois par mois. Toutefois, une part non négligeable rapporte des usages réguliers, hebdomadaires voire pluri-hebdomadaires, indiquant l'existence de pratiques plus installées au sein d'un sous-groupe spécifique. Cette configuration rejoint les résultats des enquêtes nationales, qui décrivent le cannabis comme une substance largement expérimentée mais dont l'usage régulier reste concentré sur une fraction limitée de la population étudiante.

Néanmoins, la proportion d'usages réguliers observée dans notre échantillon semble légèrement supérieure à celle rapportée dans certaines études nationales. Cet écart peut être lié à des effets de composition de l'échantillon ou à des spécificités contextuelles du milieu universitaire étudié, et invite à interpréter ces résultats avec prudence.

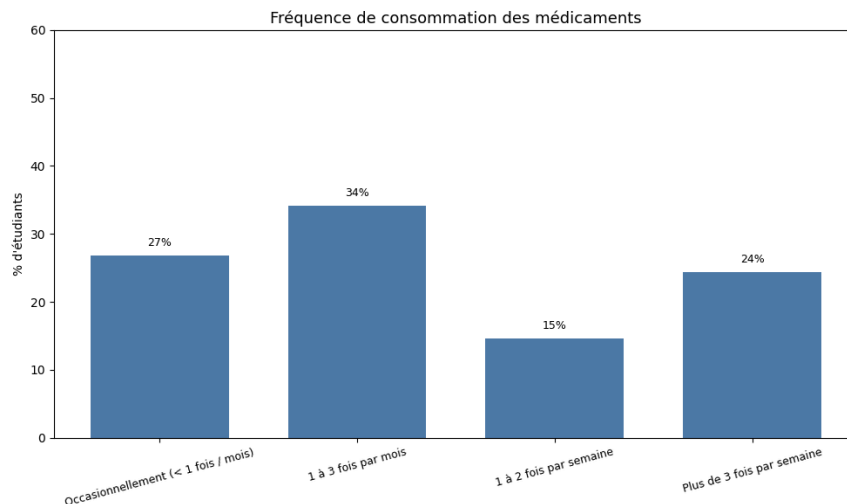


Médicaments

Une partie des étudiants déclare recourir à des médicaments afin de gérer le stress, le sommeil, la fatigue ou les difficultés de concentration. Si cette consommation ne concerne pas la majorité des répondants, elle n'en demeure pas marginale : près de 40 % des étudiants indiquent une prise au moins mensuelle, et une proportion non négligeable rapporte des usages hebdomadaires, voire plus fréquents. Ces résultats suggèrent que le recours aux médicaments s'inscrit, pour certains étudiants, dans des pratiques relativement installées.

Cette fréquence d'utilisation peut être interprétée à la lumière des travaux issus de la littérature, qui mettent en évidence une tendance croissante à la médicalisation de la gestion du stress et des performances académiques chez les jeunes adultes. Plusieurs études soulignent que les périodes de forte pression universitaire, notamment liées à la charge de travail, au manque de sommeil et aux exigences de performance, favorisent le recours à des solutions perçues comme rapides et efficaces, telles que les médicaments visant le sommeil, l'anxiété ou la vigilance.

Les résultats observés dans cette enquête s'inscrivent globalement dans cette dynamique. Le recours aux médicaments apparaît ainsi moins comme un comportement isolé que comme une stratégie d'adaptation complémentaire, voire substitutive, à d'autres modes de régulation du stress étudiant. Cette tendance soulève des enjeux importants en matière de prévention et de santé publique, en particulier lorsqu'elle s'inscrit dans la durée ou s'effectue en dehors d'un cadre médical strict.



2. Analyse des liens entre stress et comportements addictifs

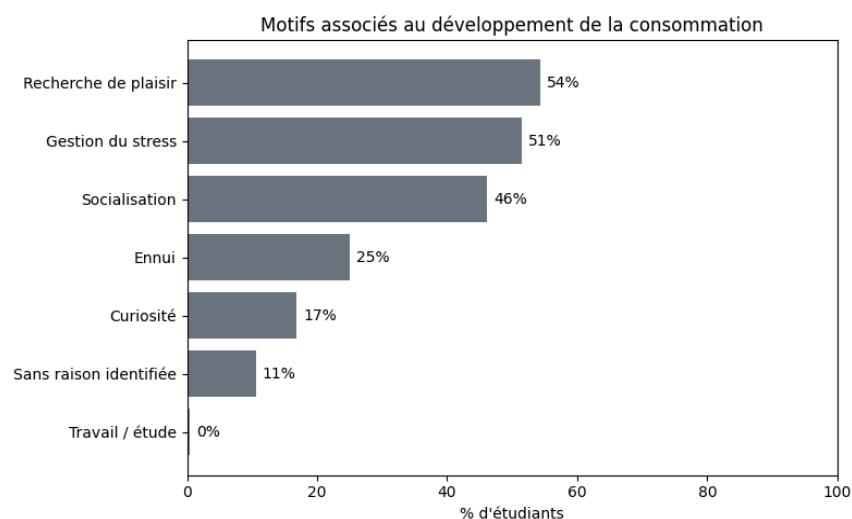
2.1 Stress académique stratégies de gestion

L'analyse des réponses met en évidence que les comportements de consommation observés chez les étudiants ne relèvent pas de pratiques isolées ou aléatoires, mais s'inscrivent dans des stratégies de gestion du stress académique clairement identifiées. Les motifs déclarés par les répondants révèlent que ces comportements répondent à des logiques multiples, mêlant recherche de régulation émotionnelle, adaptation aux contraintes universitaires et dimensions sociales.

Trois motifs dominants structurent nettement les réponses. La recherche de plaisir constitue le premier facteur cité (54 %), suivie de très près par la gestion du stress (51 %) et la socialisation (46 %). Cette hiérarchie met en évidence un point central : les comportements de consommation ne peuvent être réduits à une seule logique compensatoire liée au stress, mais s'inscrivent dans un équilibre entre bien-être subjectif, pression académique et intégration sociale. Le stress apparaît ainsi comme un déterminant majeur, mais non exclusif, des pratiques observées.

À l'inverse, les motifs plus passifs ou circonstanciels, tels que l'ennui (25 %) ou la curiosité (17 %), occupent une place secondaire. De même, la faible proportion de répondants déclarant consommer « sans raison identifiée » (11 %) suggère que ces comportements sont, dans la majorité des cas, perçus comme intentionnels et fonctionnels. Fait notable, le motif explicitement lié au travail ou aux études n'est jamais cité de manière directe, ce qui indique que les étudiants n'associent pas spontanément leurs consommations à une contrainte académique explicite, mais plutôt à des besoins intermédiaires tels que la gestion du stress, du plaisir ou des interactions sociales.

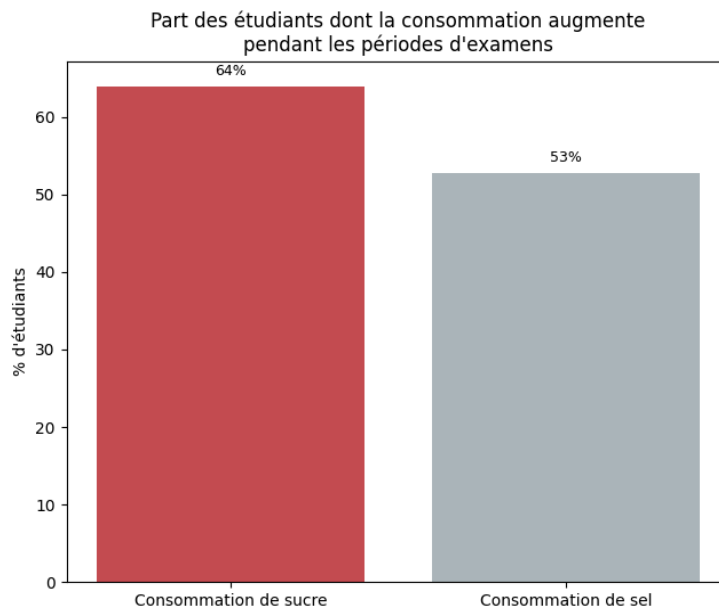
Ces résultats confirment que les stratégies de gestion du stress étudiant s'appuient sur des comportements socialement intégrés et perçus comme légitimes, plutôt que sur des réponses explicitement reconnues comme liées à la pression académique. Cette dissociation entre la cause structurelle du stress et les justifications subjectives de la consommation constitue un élément clé pour comprendre la normalisation progressive de certaines pratiques au cours des études.



2.2 Stratégies de gestion

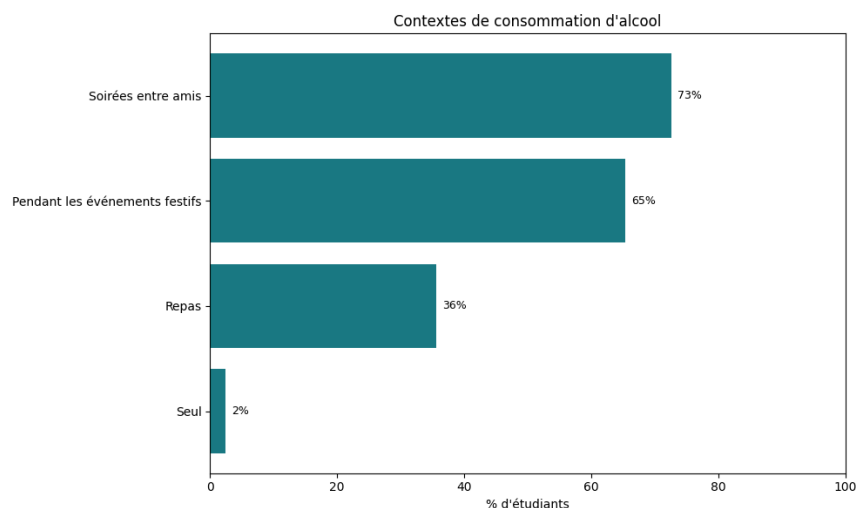
Parallèlement, les résultats mettent en évidence des stratégies de compensation émotionnelle reposant sur l'alimentation. Le grignotage, qu'il soit sucré ou salé, apparaît comme une réponse fréquente aux tensions liées aux études, en particulier lors des périodes d'examens. Cette dynamique est clairement observable, puisque 64 % des étudiants déclarent une augmentation de leur consommation de produits sucrés, contre 53 % pour les produits salés.

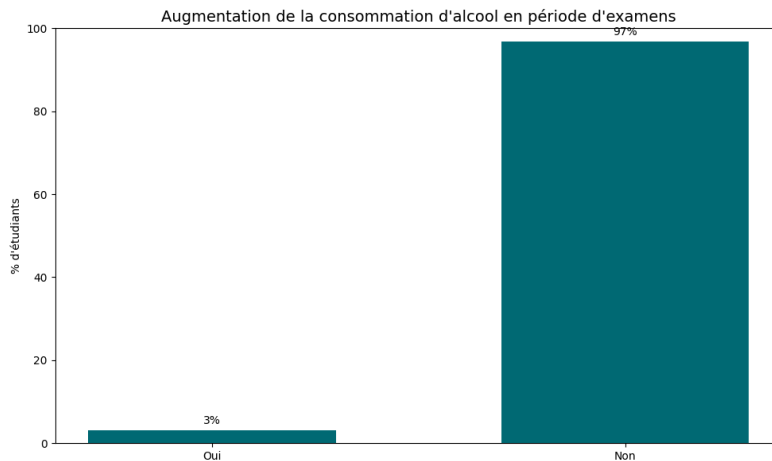
Cet écart souligne le rôle spécifique des aliments sucrés dans la régulation émotionnelle, davantage mobilisés pour apaiser le stress que pour soutenir la performance académique. L'intensification de ces comportements en période d'examens renforce ainsi l'hypothèse d'un recours à l'alimentation comme mécanisme de gestion du stress, souvent automatique et peu conscientisé, et largement banalisé dans le quotidien étudiant.



À côté de ces stratégies, certaines pratiques relèvent davantage d'une gestion indirecte ou différée du stress, fondée sur la détente et la déconnexion. La consommation d'alcool s'inscrit principalement dans cette logique. Les résultats montrent qu'elle est largement associée à des contextes sociaux et festifs, tels que les soirées entre amis ou les événements collectifs, et qu'elle n'augmente pas de manière significative durant les périodes d'examens, une très large majorité des étudiants déclarant une stabilité de leur consommation à ces moments-là.

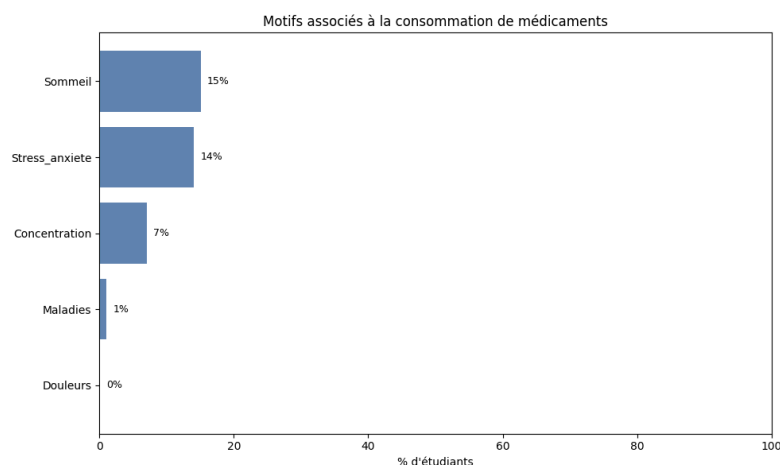
Cette absence d'augmentation apparaît cohérente avec les contraintes spécifiques des périodes d'examens, marquées par une exigence accrue de concentration, un manque de temps et une recherche d'efficacité. Dans ce contexte, l'alcool, dont les effets sont peu compatibles avec la performance académique immédiate, ne constitue pas une réponse fonctionnelle au stress universitaire. Ces résultats confirment ainsi que toutes les consommations ne sont pas mobilisées comme des réponses directes au stress académique, certaines relevant davantage de la socialisation ou de la coupure temporaire avec le cadre universitaire.





Enfin, une autre forme de gestion du stress apparaît à travers le recours aux médicaments, principalement mobilisés pour améliorer le sommeil (15 %) ou réduire le stress et l'anxiété (14 %), et plus marginalement pour soutenir la concentration (7 %). Bien que ces pratiques concernent une minorité des répondants, elles traduisent une approche plus médicalisée de la gestion du stress académique.

Les motifs déclarés indiquent une volonté de traiter directement les symptômes du stress, plutôt que de recourir à des stratégies de compensation indirectes, telles que l'alimentation ou les substances stimulantes. Cette logique distingue clairement le recours aux médicaments des autres comportements observés, en l'inscrivant dans une démarche perçue comme plus ciblée et fonctionnelle face aux exigences universitaires.



Les réponses aux questions globales sur les motivations de consommation confirment cette lecture transversale. Le sommeil et la gestion du stress apparaissent comme des motifs centraux, aux côtés de la recherche de plaisir et de la socialisation. Ces résultats soulignent la diversité des stratégies mobilisées par les étudiants pour faire face aux contraintes universitaires. Les comportements observés ne relèvent donc pas d'une logique unique, mais d'adaptations différenciées, étroitement liées au contexte académique et aux ressources individuelles.

Encadré – Perception étudiante des motivations de consommation

Au-delà des résultats quantitatifs, les réponses aux questions ouvertes apportent un éclairage complémentaire sur les motivations perçues par les étudiants eux-mêmes. Certaines formulations permettent d'illustrer de manière concrète le rôle de l'environnement social et culturel dans le développement de certaines consommations.

Par exemple, un répondant indique explicitement :

« La société m'a amené à en consommer du à mon environnement aussi »,
mettant en évidence une perception de la consommation comme un phénomène largement influencé par le contexte social, plutôt que comme un choix strictement individuel.

D'autres réponses soulignent l'influence des représentations culturelles associées à certaines pratiques. Ainsi, un étudiant évoque :

« Les films sous l'influence de l'alcool avec une cigarette est l'une des plus belles choses »,

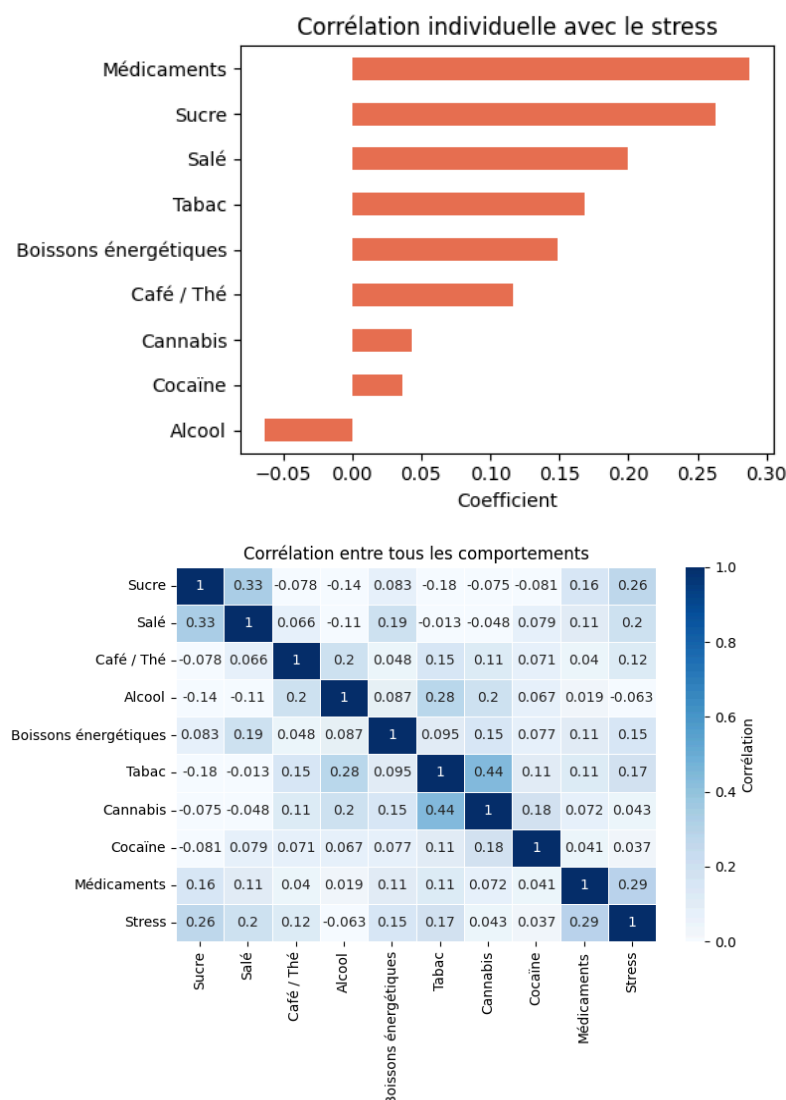
Ce qui illustre la valorisation symbolique de certaines consommations à travers des références médiatiques et culturelles.

Ces citations viennent renforcer les résultats quantitatifs en montrant que les comportements observés ne relèvent pas uniquement de la gestion du stress académique, mais s'inscrivent également dans des dynamiques sociales et culturelles plus larges. Elles suggèrent que certaines consommations sont perçues comme normales ou attractives dans le cadre de la vie étudiante, ce qui peut contribuer à leur maintien, indépendamment du niveau de stress ressenti.

3. Discussion et recommandations

3.1 Analyses croisées et interprétation

Avant de procéder aux analyses croisées, une matrice de corrélation a été construite afin d'identifier les relations statistiques entre le stress académique et les principales variables de consommation. La corrélation permet ici de mesurer l'intensité et le sens de la relation entre deux variables, sans présumer d'un lien de causalité. Cette étape méthodologique vise ainsi à orienter l'analyse vers les croisements les plus pertinents et à éviter des interprétations arbitraires.



Les résultats mettent en évidence des corrélations positives, bien que modérées, entre le stress académique et plusieurs comportements de consommation. Les coefficients les plus élevés concernent notamment la consommation de médicaments ($r \approx 0,29$), de produits sucrés ($r \approx 0,26$) et, dans une moindre mesure, les produits salés et le tabac (r compris entre 0,15 et 0,20). Ces valeurs, sans être élevées, traduisent une association statistique non

négligeable, suggérant que ces consommations tendent à augmenter lorsque le niveau de stress déclaré s'élève.

Ces comportements semblent relever de stratégies perçues comme fonctionnelles face aux exigences académiques, qu'il s'agisse de lutter contre la fatigue, d'améliorer la concentration ou de réguler l'anxiété. Les corrélations observées avec le café/thé ou les boissons énergisantes, bien que plus faibles ($r \approx 0,10$ à $0,15$), vont également dans ce sens, confirmant l'usage de stimulants comme réponse ponctuelle au stress universitaire.

À l'inverse, l'alcool constitue la seule consommation présentant une corrélation négative avec le stress académique ($r \approx -0,06$). Bien que de faible intensité, cette corrélation mérite une attention particulière, car elle se distingue clairement des autres comportements analysés. Les données descriptives associées montrent que les étudiants se déclarant stressés consomment légèrement moins d'alcool que ceux déclarant un faible niveau de stress (73,8 % contre 79,2 %). Ce résultat suggère que l'alcool ne s'inscrit pas, dans cet échantillon, comme une stratégie privilégiée de gestion du stress académique.

Cette tendance peut s'expliquer par une réduction des consommations festives en période de forte charge de travail, ou par un arbitrage en faveur de consommations perçues comme plus compatibles avec les exigences universitaires. Elle met en évidence une distinction nette entre des consommations à visée sociale, telles que l'alcool, et des consommations davantage orientées vers la gestion immédiate des contraintes académiques.

Enfin, la matrice de corrélation révèle également des relations entre certaines consommations indépendamment du stress, notamment entre le tabac et le cannabis ($r \approx 0,44$), ou entre le sucre et le sel ($r \approx 0,33$). Ces corrélations traduisent des logiques de co-usage ou d'habitudes alimentaires et comportementales associées, confirmant l'intérêt d'une analyse transversale des comportements addictifs.

Dans l'ensemble, les corrélations observées, bien que majoritairement de faible à moyenne intensité, mettent en évidence des tendances cohérentes avec les pratiques étudiantes et fournissent un cadre analytique solide pour l'interprétation globale des résultats et les recommandations formulées par la suite.

En quelle année d'étude supérieure êtes-vous ?	Femme	Homme	Je ne souhaite pas le préciser	Total
BAC +1	3,85 %	6,25 %		10,10 %
BAC +2	6,73 %	2,88 %		9,62 %
BAC +3	8,17 %	8,17 %		16,35 %
BAC +4	13,94 %	12,98 %	0,96 %	27,88 %
BAC +5	16,35 %	18,27 %	0,48 %	35,10 %
Doctorant	0,96 %			0,96 %
Total	50,00 %	48,56 %	1,44 %	100,00 %

Tableau 1 — Année d'étude × Genre

Le premier tableau met en évidence une forte concentration des répondants dans les niveaux d'études avancés. Les étudiants en BAC +4 (27,9 %) et BAC +5 (35,1 %) représentent à eux seuls plus de 63 % de l'échantillon, tandis que les niveaux de début de

cursus demeurent minoritaires. Cette structure suggère que les résultats reflètent majoritairement l'expérience d'étudiants ayant déjà une exposition prolongée aux exigences académiques, aux enjeux de performance et aux incertitudes liées à l'orientation ou à l'insertion professionnelle.

La répartition par genre apparaît globalement équilibrée sur l'ensemble des niveaux d'étude, limitant ainsi les biais d'interprétation liés à une surreprésentation d'un sexe à un stade particulier du parcours universitaire. Ce profil de panel renforce l'idée que les comportements observés relèvent moins d'expérimentations ponctuelles que de stratégies d'adaptation progressivement installées au cours des études.

Addiction	Non	Oui
Alcool	17,79 %	82,21 %
Boissons_énergisantes	29,81 %	70,19 %
Café_Thé	25,96 %	74,04 %
Cannabis	21,15 %	78,85 %
Cigarettes_électroniques_Puffs	24,04 %	75,96 %
Cigarettes_tabac	15,38 %	84,62 %
Médicaments	33,65 %	66,35 %
Sel	50,96 %	49,04 %
Sucre	18,75 %	81,25 %
Total	26,39 %	73,61 %

Tableau 2 — Perception d'addiction par type de consommation

Le croisement entre les types de consommation et la déclaration d'addiction met en évidence une hiérarchisation très nette des perceptions. Les substances traditionnellement identifiées comme addictives présentent des taux de reconnaissance élevés : 84,6 % pour le tabac, 82,2 % pour l'alcool et 78,9 % pour le cannabis. Toutefois, des niveaux comparables sont également observés pour des consommations plus banalisées du quotidien, telles que le sucre (81,3 %) ou le café/thé (74,0 %).

À l'inverse, le sel se distingue par une reconnaissance nettement plus faible de l'addiction, avec seulement 49,0 % de réponses positives. Ce contraste met en évidence un décalage entre la fréquence potentielle d'usage et la perception du caractère addictif, suggérant que cette reconnaissance dépend davantage des représentations sociales associées aux substances que de leur consommation effective.

Dans l'ensemble, ces résultats traduisent une forte conscience déclarative des comportements de consommation chez les étudiants, tout en soulignant le caractère sélectif de cette conscience, particulièrement pour les pratiques les plus intégrées au quotidien.

Raison	Non	Oui
Aucune_raison	89,42 %	10,58 %
Curiosite	83,17 %	16,83 %
Ennui	75,00 %	25,00 %
Gestion_stress	48,56 %	51,44 %
Recherche_plaisir	45,67 %	54,33 %
Socialisation	53,85 %	46,15 %
Travail	99,52 %	0,48 %
Total	70,74 %	29,26 %

Tableau 3 — Raisons invoquées × Déclaration de consommation

Le croisement entre les raisons invoquées et la déclaration de consommation révèle que les comportements observés sont rarement perçus comme dénués de justification. Les motivations dominantes sont la recherche de plaisir (54,3 %) et la gestion du stress (51,4 %), suivies de la socialisation (46,2 %). À l'inverse, les motifs plus passifs tels que l'ennui (25,0 %) ou la curiosité (16,8 %) occupent une place secondaire.

Il est particulièrement notable que le motif explicitement lié au travail ou aux études soit quasi absent (0,5 %), alors même que le stress académique est largement reconnu dans l'ensemble du questionnaire. Ce résultat suggère une dissociation entre la source structurelle du stress et la manière dont les étudiants justifient leurs consommations, celles-ci étant davantage associées à des besoins émotionnels ou relationnels qu'à des contraintes académiques directement formulées.

Cette tendance confirme que les comportements de consommation sont perçus comme intentionnels et fonctionnels, inscrits dans des logiques de régulation plutôt que dans des réponses impulsives ou non maîtrisées.

Augmentation en période d'examen	Non	Oui
Alcool	96,86 %	3,14 %
Boissons énergisantes	42,67 %	57,33 %
Café/Thé	36,77 %	63,23 %
Cannabis	86,67 %	13,33 %
Cigarettes	50,91 %	49,09 %
Cocaïne	100,00 %	
Médicaments	26,83 %	73,17 %
Sel	47,30 %	52,70 %
Sucre	36,03 %	63,97 %
Total	54,26 %	45,74 %

Tableau 4 — Augmentation en période d'examens × Type de consommation

Le dernier tableau met en évidence une différenciation très marquée des comportements en période d'examens. Certaines consommations connaissent une augmentation significative, notamment les médicaments (73,2 %), le sucre (64,0 %), le café/thé (63,2 %) et les boissons énergisantes (57,3 %). Ces substances apparaissent comme compatibles avec les exigences de concentration, de gestion du temps et de performance académique.

À l'inverse, les consommations à forte dimension sociale ou récréative demeurent largement stables. L'alcool n'augmente que pour 3,1 % des étudiants, le cannabis pour 13,3 %, tandis que certaines substances ne connaissent aucune augmentation déclarée. Cette opposition met en évidence une réallocation des usages plutôt qu'une hausse généralisée des consommations en période de stress intense.

Ces résultats suggèrent que les périodes d'examens agissent comme un filtre comportemental, orientant les choix vers des stratégies perçues comme fonctionnelles et évitant celles jugées incompatibles avec la performance académique immédiate.

3.2 Lecture transversale des tableaux croisés

Pris dans leur ensemble, les tableaux croisés dynamiques confirment que le stress académique ne produit pas des comportements homogènes, mais conduit à une hiérarchisation implicite des stratégies de consommation. Les étudiants adaptent leurs pratiques en fonction du contexte, mobilisant tour à tour des réponses fonctionnelles, émotionnelles ou médicalisées, tout en maintenant une distinction nette entre les usages liés à la performance et ceux relevant de la socialisation ou de la détente.

Cette analyse met ainsi en évidence que les comportements observés ne peuvent être interprétés comme des signes uniformes d'addiction, mais comme des adaptations situées, dépendantes à la fois du contexte académique et des ressources individuelles mobilisées face aux contraintes universitaires.

3.3 Mise en perspective et limites de l'étude

Les résultats issus de cette enquête peuvent être mis en perspective avec les données nationales disponibles sur les comportements de consommation des jeunes adultes et des étudiants, notamment celles publiées par l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le choix des modalités de réponse du questionnaire a permis cette comparaison, en s'appuyant sur des indicateurs fréquemment utilisés dans les enquêtes institutionnelles (fréquence de consommation, évolution dans le temps, usage en contexte de stress).

Consommation d'alcool

Selon les données nationales de l'OFDT, environ 80 % des jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans déclarent consommer de l'alcool, avec une majorité d'usages occasionnels à réguliers, principalement dans des contextes festifs ou sociaux. Dans notre étude, 76,6 % des répondants déclarent consommer de l'alcool, un niveau très proche des statistiques nationales, ce qui suggère une bonne cohérence globale entre notre échantillon et la population étudiante française.

En revanche, la fréquence de consommation observée dans notre enquête apparaît légèrement plus modérée. Une part importante des étudiants déclare une consommation occasionnelle ou mensuelle, tandis que les usages très fréquents restent minoritaires. Cette différence peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment la structure géographique de l'échantillon, une part significative des répondants étant issus d'un même bassin universitaire, ce qui limite la diversité des contextes sociaux et culturels comparativement à une enquête nationale.

Par ailleurs, notre étude montre que la consommation d'alcool n'augmente pas significativement pendant les périodes d'examens, ce qui est cohérent avec les enquêtes nationales indiquant que l'alcool est avant tout associé à la socialisation plutôt qu'à la gestion du stress académique.

Consommation de café et stimulants

Les données nationales indiquent que la consommation de café est très largement répandue chez les étudiants, avec une majorité déclarant une consommation quotidienne. Dans notre enquête, près de trois quarts des répondants consomment du café ou du thé, et une part importante déclare une consommation quotidienne ou quasi quotidienne. Ces résultats sont donc alignés avec les constats nationaux, confirmant le caractère banalisé et fonctionnel de ces consommations.

En période d'examens, plus d'un tiers des étudiants interrogés déclarent une augmentation de leur consommation de café ou de thé. Cette proportion est cohérente avec les travaux de l'OFDT et de l'OMS, qui soulignent une augmentation des usages de stimulants en situation de stress académique, sans que ces pratiques soient nécessairement perçues comme addictives au sens clinique.

Grignotage et alimentation

Les enquêtes nationales montrent que les comportements alimentaires déséquilibrés sont fréquents chez les jeunes adultes, notamment en contexte d'études supérieures. Dans notre étude, le grignotage sucré et salé concerne une part importante des étudiants, avec une augmentation déclarée depuis l'entrée dans l'enseignement supérieur pour une proportion significative des répondants. Cette évolution est conforme aux tendances observées au niveau national, où l'alimentation est souvent identifiée comme une variable sensible au stress et aux contraintes organisationnelles.

La hausse du grignotage pendant les périodes d'examens observée dans notre échantillon va également dans le sens des résultats issus d'études françaises, qui montrent une utilisation accrue de l'alimentation comme stratégie de compensation émotionnelle en situation de pression.

Tabac, cannabis et autres substances

Les niveaux de consommation de tabac et de cannabis observés dans notre enquête apparaissent légèrement inférieurs aux moyennes nationales pour les jeunes adultes. Selon l'OFDT, environ un quart des 18–25 ans fument régulièrement, tandis que la proportion observée dans notre échantillon est plus faible. Cette différence peut s'expliquer par la composition spécifique de l'échantillon, mais également par un possible biais de déclaration, certaines consommations restant socialement sensibles.

Concernant les substances illicites plus rares, telles que la cocaïne, la très faible proportion de consommateurs observée est cohérente avec les données nationales, mais ne permet aucune analyse approfondie compte tenu du faible nombre de répondants concernés.

Limites liées à la comparabilité

Malgré ces convergences, certaines limites doivent être soulignées. La taille et la structure de l'échantillon ne permettent pas une généralisation stricte à l'ensemble des étudiants français. De plus, la forte concentration géographique des répondants limite la diversité des profils socio-culturels. Enfin, bien que les indicateurs utilisés soient comparables à ceux des enquêtes nationales, les données restent auto-déclarées et ne reposent pas sur des outils cliniques standardisés.

Néanmoins, les résultats obtenus apparaissent largement cohérents avec les grandes tendances nationales, ce qui renforce la crédibilité de l'étude et confirme la pertinence des choix méthodologiques effectués.

3.4 Préconisations et pistes d'action

Au regard des résultats, plusieurs pistes d'action peuvent être envisagées afin de mieux accompagner les étudiants dans la gestion du stress académique et de prévenir le développement de comportements addictifs problématiques.

Une première recommandation concerne le renforcement des actions de prévention ciblées sur le stress universitaire. Les résultats suggèrent que de nombreuses consommations s'inscrivent dans une logique de gestion du stress, ce qui souligne l'intérêt de dispositifs visant à agir en amont, notamment par la sensibilisation aux mécanismes du stress, à ses effets et aux stratégies de régulation alternatives.

Il apparaît également pertinent de promouvoir des stratégies de gestion du stress non addictives, déjà largement évoquées par les étudiants dans leurs réponses, telles que le sport, les activités de loisirs, les interactions sociales ou les techniques de relaxation. La valorisation de ces pratiques au sein des établissements d'enseignement supérieur pourrait contribuer à réduire le recours à des comportements de compensation moins sains.

Par ailleurs, les résultats mettent en lumière une utilisation non négligeable de substances perçues comme fonctionnelles (café, médicaments), souvent banalisées. Des actions d'information pourraient ainsi viser à mieux encadrer ces consommations, en sensibilisant les étudiants aux risques liés à l'usage excessif, sans adopter une approche culpabilisante.

Enfin, cette étude ouvre des perspectives pour des travaux futurs. Une enquête reposant sur un échantillon plus large et plus diversifié, ou intégrant des outils de mesure standardisés du stress et des comportements addictifs, permettrait d'approfondir les liens observés. Une approche qualitative, par entretiens, pourrait également enrichir la compréhension des motivations et des trajectoires individuelles.

Dans l'ensemble, les résultats soulignent l'importance d'une approche globale de la prévention en milieu universitaire, intégrant à la fois les conditions d'études, la gestion du stress et les habitudes de vie des étudiants.

Annexes

Annexe A – Questionnaire

Le questionnaire utilisé dans le cadre de cette étude est présenté en annexe sous forme de document PDF, correspondant à la version exacte diffusée aux répondants.

Étudiants face aux addictions comportementales

Ce questionnaire anonyme s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche en Technique d'Enquêtes. L'objectif est de comprendre dans quelle mesure les étudiants utilisent certaines substances ou habitudes de consommation comme stratégie pour gérer le stress lié aux études au cours des 12 derniers mois. Merci pour votre participation.

** Indique une question obligatoire*

1. En quelle année d'étude supérieure êtes-vous ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ BAC +1
- ☐ BAC +2
- ☐ BAC +3
- ☐ BAC +4
- ☐ BAC +5
- ☐ Doctorant
- ☐ Je ne suis pas en étude supérieure

Substances consommables

Par « substance consommable », on entend tout produit que l'on peut ingérer ou consommer de façon régulière et qui peut créer une habitude ou une dépendance.

2. Considérez-vous être une personne addictive à une substance consommable ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non

3. Selon vous, qu'est-ce qui peut être considéré comme une addiction comportementale ? (*plusieurs réponses possibles*)

*

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Sucre (gateaux, bonbons, chocolats, boissons sucrées, ...)
- ☐ Sel (chips, sandwich industriels,...)
- ☐ Café/Thé
- ☐ Alcool
- ☐ Boissons énergisantes (RedBull, Monster, ...)
- ☐ Cigarettes (ou équivalent tabac/chicha)
- ☐ Cigarettes électroniques/Puffs
- ☐ Cannabis (shit, beuh, CBD) / Cocaïne
- ☐ Médicaments

Analyse de votre consommation

Les prochaines questions ont pour objectif de mieux comprendre vos habitudes de consommation (boissons, aliments, tabac, etc.) ainsi que leur fréquence.

Grignotage sucré

Au cours des 12 derniers mois.

4. Avez-vous tendance à grignoter des produits sucrés (gâteaux, bonbons, chocolat, biscuits, etc.) en dehors des repas ?

*

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non *Passer à la question 8*

Fréquence de grignotage sucré

Au cours des 12 derniers mois.

5. À quelle fréquence ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Très rarement (moins de 3 fois par mois)
- ☐ Rarement (1 à 2 fois par semaine)
- ☐ Parfois (3 à 4 fois par semaine)
- ☐ Souvent (presque tous les jours)
- ☐ Très souvent (plusieurs fois par jour)

6. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? *
(augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.)

Une seule réponse possible.

- ☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

7. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non

 Grignotage salé

Au cours des 12 derniers mois.

8. Avez-vous tendance à grignoter des produits salés (chips, sandwich industriels, * etc.) en dehors des repas ?

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
☐ Non *Passer à la question 12*

 Fréquence de grignotage salé

9. À quelle fréquence ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Très rarement (moins de 3 fois par mois)
☐ Rarement (1 à 2 fois par semaine)
☐ Parfois (3 à 4 fois par semaine)
☐ Souvent (presque tous les jours)
☐ Très souvent (plusieurs fois par jour)

10. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué * ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.)

Une seule réponse possible.

- ☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études
☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté
☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué
☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

11. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
☐ Non

 Café / Thé

Au cours des 12 derniers mois.

12. Buvez-vous du café/thé ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non *Passer à la question 16*

 Fréquence de consommation de Café/Thé

Au cours des 12 derniers mois.

13. En moyenne, combien de tasses de café ou de thé consommez-vous par jour ? *

Une seule réponse possible.

☐ Moins souvent

☐ 1 tasse tous les 2 jours

☐ 1 à 2 tasses par jour

☐ 3 à 5 tasses par jour

☐ 6 tasses ou plus par jour

14. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.) *

Une seule réponse possible.

☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études

☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté

☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué

☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

15. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

Alcool

Au cours des 12 derniers mois.

16. Consommez-vous de l'alcool (bière, vin, spiritueux, cocktails, etc.) ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non *Passer à la question 22*

Fréquence de votre consommation d'alcool

Au cours des 12 derniers mois.

17. À quelle fréquence consommez-vous de l'alcool ? *

Une seule réponse possible.

☐ Occasionnellement (une fois par mois ou moins)

☐ Parfois (2 à 4 fois par mois)

☐ Régulièrement (2 à 3 fois par semaine)

☐ 4 fois ou plus par semaine

18. Lors d'un jour typique où vous buvez de l'alcool, combien de **verres standard** consommez-vous ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ 1 à 2 verres
- ☐ 3 à 4 verres
- ☐ 5 à 6 verres
- ☐ 7 à 9 verres
- ☐ 10 verres ou plus

19. Dans quels contextes consommez-vous le plus souvent de l'alcool ? (*plusieurs réponses possibles*) *

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Seul
- ☐ Soirées entre amis (bar, lieu privée,...)
- ☐ Repas (famille, restaurant, etc.)
- ☐ Pendant les événements festifs (anniversaires, sorties étudiantes, etc.)

20. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.) *

Une seule réponse possible.

- ☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

21. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

 Boissons énergisantes

Au cours des 12 derniers mois.

22. Consommez-vous des boissons énergisantes (RedBull, Monster,...) ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non *Passer à la question 26*

 Fréquence de consommation de boissons énergisantes

Au cours des 12 derniers mois.

23. À quelle fréquence en consommez-vous ? *

Une seule réponse possible.

☐ moins d'une canette / occasionnellement

☐ 1 canette / semaine

☐ 2 à 3 canettes / semaine

☐ plus de 3 canettes / semaine

☐ tous les jours

24. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.) *

Une seule réponse possible.

- ☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

25. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non

 Tabac (cigarettes, chicha, etc.)

Au cours des 12 derniers mois.

26. Consommez-vous des cigarettes (ou équivalent tabac/chicha) ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non *Passer à la question 30*

 Fréquence de consommation de tabac

Au cours des 12 derniers mois.

27. Combien de cigarettes consommez-vous en moyenne par jour ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Moins souvent
- ☐ 1 à 5
- ☐ 6 à 10
- ☐ 11 à 20
- ☐ 20 à 25
- ☐ Plus de 25 par jours

28. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.) *

Une seule réponse possible.

- ☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

29. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non

Cannabis

Au cours des 12 derniers mois.

30. Consommez-vous du cannabis (joint, résine, herbe, etc.) ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non *Passer à la question 34*

 **Fréquence de consommation de cannabis**

Au cours des 12 derniers mois.

31. À quelle fréquence consommez-vous du cannabis ? *

Une seule réponse possible.

☐ Occasionnellement (moins d'une fois par mois)

☐ 1 à 3 fois par mois

☐ 1 à 2 fois par semaine

☐ Plus de 3 fois par semaine

32. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.) *

Une seule réponse possible.

☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études

☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté

☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué

☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

33. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

● **Cocaïne**

Au cours des 12 derniers mois.

34. Consommez-vous de la cocaïne ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non *Passer à la question 38*

🕒 **Fréquence de consommation de la cocaïne**

Au cours des 12 derniers mois.

35. À quelle fréquence consommez-vous de la cocaïne ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Occasionnellement (moins d'une fois par mois)
- ☐ 1 à 3 fois par mois
- ☐ 1 à 2 fois par semaine
- ☐ Plus de 3 fois par semaine

36. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.) *

Une seule réponse possible.

- ☐ Je ne consommait pas avant, j'ai commencé pendant mes études
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a augmenté
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation a diminué
- ☐ Je consommait déjà, mais ma consommation est identique

37. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

 Médicaments (anti-stress, anti-fatigue, etc.)

Pour un usage hors traitement strictement médical.

Au cours des 12 derniers mois.

38. Consommez-vous des médicaments pour gérer le stress, la fatigue, le sommeil *
ou la concentration ?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non *Passer à la question 43*

 Fréquence de consommation de médicaments

Pour un usage hors traitement strictement médical.

Au cours des 12 derniers mois.

39. À quelle fréquence consommez-vous des médicaments ? *

Une seule réponse possible.

☐ Occasionnellement (< 1 fois / mois)

☐ 1 à 3 fois par mois

☐ 1 à 2 fois par semaine

☐ Plus de 3 fois par semaine

40. Pour quelle(s) raison(s) ? (*plusieurs réponses possibles*) *

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Réduire le stress / l'anxiété
- ☐ Améliorer le sommeil
- ☐ Combattre la fatigue
- ☐ Améliorer la concentration
- ☐ Autre : _____

41. Depuis le début de vos études supérieures, votre consommation a-t-elle évolué ? (augmenté, diminué, restée stable, commencée à ce moment-là, etc.) *

Une seule réponse possible.

- ☐ Je ne consommais pas avant, j'ai commencé pendant mes études
- ☐ Je consommais déjà, mais ma consommation a augmenté
- ☐ Je consommais déjà, mais ma consommation a diminué
- ☐ Je consommais déjà, mais ma consommation est identique

42. Votre consommation augmente-t-elle pendant les périodes d'examens ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non

Questions globales

43. Pour quelles raisons pensez-vous avoir développé cette/ces consommation(s) *
? (*plusieurs réponses possibles*)

Plusieurs réponses possibles.

- ☐ Gestion du stress
- ☐ Recherche de plaisir
- ☐ Socialisation (intégration, sorties, influence)
- ☐ Ennui ou routine
- ☐ Curiosité / expérimentation
- ☐ Aucune raison / Je ne sais pas
- ☐ Autre : _____

44. En dehors de la consommation de substances, quelles sont les principales activités ou stratégies (loisirs, habitudes, comportements...) que vous utilisez pour vous déconnecter ou faire une pause face au stress des études ?

Pour Terminer

45. Quel est votre genre ? *

Une seule réponse possible.

- ☐ Femme
- ☐ Homme
- ☐ Je ne souhaite pas le préciser
- ☐ Autre : _____

46. Avez-vous d'autres commentaires, remarques, ou informations importantes à partager concernant votre gestion du stress et vos études, et qui n'auraient pas été abordés dans ce questionnaire ?

Précision

Selon la littérature en psychologie et en sciences du comportement, le terme *addiction* englobe aussi bien les substances psychoactives que certaines consommations ou habitudes répétées visant à réguler le stress. Ainsi, toutes les substances citées dans ce questionnaire (sucre, sel, café, thé, alcool, boissons énergisantes, tabac, cigarettes électroniques, cannabis, médicaments, etc.) peuvent être considérées comme des formes d'addiction potentielles. Cette précision a pour objectif d'apporter une définition commune des termes utilisés et de clore le questionnaire sur une compréhension partagée du concept étudié.

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Google Forms

Annexe B – Bibliographie et webographie

Sources institutionnelles et officielles

Observatoire français des drogues et des tendances addictives. (2018). Addictions comportementales : synthèse des connaissances. OFDT.

<https://www.ofdt.fr/addictions-comportementales-synthese-des-connaissances-2068>

Observatoire français des drogues et des tendances addictives. (2023). Alcool : synthèse des connaissances. OFDT.

<https://www.ofdt.fr/alcool-synthese-des-connaissances-1722>

Observatoire français des drogues et des tendances addictives. (2023). Tabac, cigarettes, tabac chauffé : synthèse des connaissances. OFDT.

<https://www.ofdt.fr/tabac-cigarettes-tabac-chauffe-synthese-des-connaissances-1723>

Observatoire français des drogues et des tendances addictives. (2023). Cigarette électronique et e-liquides légalement accessibles : synthèse des connaissances. OFDT.

<https://www.ofdt.fr/cigarette-electronique-et-e-liquides-legalement-accessibles-synthese-des-connaissances-1725>

Observatoire français des drogues et des tendances addictives. (2024). Drogues et addictions : données et analyses 2024. OFDT.

https://www.ofdt.fr/sites/ofdt/files/2025-01/dacc_2024.pdf

Ministère des Solidarités et de la Santé. (s.d.). Qu'est-ce qu'une drogue ? Drogues Info Service.

<https://www.drogues.gouv.fr/quest-ce-quune-drogue>

Ministère des Solidarités et de la Santé. (2023). Les consommations de tabac, alcool et cannabis des jeunes Français.

<https://www.drogues.gouv.fr/les-consommations-de-tabac-alcool-et-cannabis-des-jeunes-francais-en-baisse-constante-depuis-plus>

Addictions France. (2023). Drogues et opinion publique : les perceptions des Français.

<https://addictions-france.org/actualites/drogues-et-opinion-publique-les-perceptions-des-francais-en-pleine-mutation-12419>

Organisation mondiale de la Santé. (2018). Global status report on alcohol and health. OMS.

<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/c57d9855-5450-4c46-84b1>

Organisation mondiale de la Santé. (s.d.). AUDIT – Alcohol Use Disorders Identification Test.

<https://auditscreen.org>

Haute Autorité de Santé. (2014). Test de dépendance à la nicotine de Fagerström. HAS.

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2014-11/outil_tests_fagerstrom.pdf

RESPADD. (2020). Repérage précoce et intervention brève – Tabac.

<https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2020/05/Affiche-RPIB-tabac-fev.-2020-BAT.pdf>

RESPADD. (2021). Test CDS – Dépendance au tabac.
<https://www.respadd.org/wp-content/uploads/2021/11/Test-CDS.pdf>

Sources scientifiques et académiques

Ahmed, S. H. (2012). Addiction to sugar: behavioral and neurochemical effects. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).

<https://www.u-bordeaux.fr/universite/espace-presse/repertoire-dexperts/serge-ahmed>

Gearhardt, A. N., Corbin, W. R., & Brownell, K. D. (2009). Preliminary validation of the Yale Food Addiction Scale. *Appetite*, 52(2), 430–436.

Garner, D. M. (2004). Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3). Psychological Assessment Resources.

Sources méthodologiques et design de questionnaires

LimeSurvey GmbH. (2023). Colour psychology in survey design.

<https://www.limesurvey.org>

UXMatters. (2023). Color psychology and user experience design.

<https://www.uxmatters.com>

Les seuils de consommation et les outils de repérage cités dans ces sources ont été mobilisés à titre de référence afin d'éclairer la construction du questionnaire et l'interprétation des résultats, sans prétendre à une évaluation clinique des comportements observés.